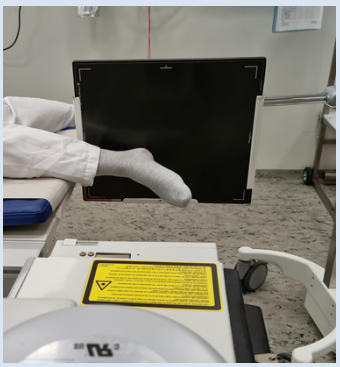
RG Ankel

Endring siden forrige versjon
Revidert. Fjernet setning om "på forespørsel fra ortoped..." og "Ofte er pasient inkludert i studie", under stående ankel. Fjernet "vrikkebilde". Fjernet suppleringsbilder ved "rotasjonsfeilstilling". Fjernet "skuffebilde".

Indikasjon	Skade, smerte, kontroll	*Front AP, Skrå, Side*
	Weber-b/Weber-c-studie	*Stående Front AP, Stående Skrå, Stående Side* ***Tilleggprojeksjon:*** *Gravity stress*
	Varus/valgus bakfot	***Tilleggsprojeksjon:*** *Salzmann view; se prosedyren RG Fot/tær*

FRONT AP		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen, uten rotasjon av aktuelt bein. Dorsalflekter til omtrent 90° i ankelleddet. Med sentrering i ankelleddet, inkluder 1/3 av distale tibia og fibula	
SENTRERING	Midt mellom malleolene	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Ankelleddet fremstilles åpent medialt, samt lukket lateralt med noe overprojeksjon mellom fibula og talus. 1/3 av distale tibia og fibula inkluderes, samt bløtdeler inkluderes på hver side.	
KOMMENTAR		
SKRÅ		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Pasient liggende på ryggen, med aktuelt bein rotert innover 15-20°, slik at linjen mellom malleolene er parallelt med detektor. Dorsalflekter til omtrent 90° i ankelleddet. Med sentrering i ankelleddet, inkluder 1/3 av distale tibia og fibula	
SENTRERING	Midt mellom malleolene	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Ankelleddet fremstilles helt åpent, med malleolene i profil. 1/3 av distale tibia og fibula inkluderes, samt bløtdeler inkluderes på hver side.	

KOMMENTAR		
SIDE		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Pasienten liggende på siden med lateralsiden av utstrakt aktuelt bein mot detektor. Beinet rotert innover 15-20°, slik at linjen mellom malleolene er vinkelrett på detektor. Dorsalflekter til omtrent 90° i ankelleddet. Med sentrering på mediale malleol, inkluderer strålefeltet 1/3 av tibia og fibula, samt fotrøtter og basen av 5. metatars.	
SENTRERING	I ankelleddet, på mediale malleol	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Ankelleddet fremstilles åpent, uten rotasjon i talus. Fibula følger bakre del av tibia og ligger fram mot midten av ankelleddet. 1/3 av tibia og fibula inkluderes, samt basen av 5. metatars.	
KOMMENTAR		
STÅENDE FRONT AP		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Belastet røntgen avdekker eventuell medial instabilitet i ankelleddet. Det er svært viktig å belaste tilstrekkelig, og at bildet tas **UTEN GIPS**.	
POSISJONERING	Som **FRONT AP**, men stående, og **UTEN GIPS**. Pasient stående med minimum lik vekt på begge beina uten å avlaste belastning med armene, og uten rotasjon av aktuelt bein. Med sentrering i ankelleddet, inkluder 1/3 av distale tibia og fibula.	
SENTRERING	Midt mellom malleolene	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Ankelleddet fremstilles åpent medialt, samt lukket lateralt med noe overprojeksjon mellom fibula og talus. 1/3 av distale tibia og fibula inkluderes, samt bløtdeler inkluderes på hver side. Bildet merkes med «stående». Ved avvik fra ønsket grad av belastning, noter avviket i bildet.	
KOMMENTAR		
STÅENDE SKRÅ		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Belastet røntgen avdekker eventuell medial instabilitet i ankelleddet. Det er svært viktig å belaste tilstrekkelig, og at bildet tas **UTEN GIPS**.	

POSISJONERING	Som **SKRÅ**, men stående, og **UTEN GIPS**. Pasient stående med minimum lik vekt på begge beina uten å avlaste belastning med armene, med aktuelt bein rotert innover 15-20°, slik at linjen mellom malleolene er parallelt med detektor. Med sentrering i ankelleddet, inkluder 1/3 av distale tibia og fibula	
SENTRERING	Midt mellom malleolene	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Ankelleddet fremstilles helt åpent, med malleolene i profil. 1/3 av distale tibia og fibula inkluderes, samt bløtdeler inkluderes på hver side. Bildet merkes med «stående». Ved avvik fra ønsket grad av belastning, noter avviket i bildet.	
KOMMENTAR		
STÅENDE SIDE		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Det er svært viktig å belaste tilstrekkelig, og at bildet tas **UTEN GIPS**.	
POSISJONERING	Som **SIDE**, men stående, og **UTEN GIPS**. Pasient stående med minimum lik vekt på begge beina uten å avlaste belastning med armene, med aktuelt bein rotert innover 15-20°, slik at linjen mellom malleolene er parallelt med detektor. Aktuelt bein foran det andre beinet. Med sentrering på mediale malleol, inkluderer strålefeltet 1/3 av tibia og fibula, samt basen av 5. metatars.	
SENTRERING	Mediale malleol	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Ankelleddet fremstilles åpent, uten rotasjon i talus. Fibula følger bakre del av tibia og ligger fram mot midten av ankelleddet. 1/3 av tibia og fibula inkluderes, samt fotrøtter med basen av 5. metatars. Bildet merkes med «stående». Ved avvik fra ønsket grad av belastning, noter avviket i bildet.	
KOMMENTAR		
GRAVITY STRESS		
INFORMASJON	Bildet defineres som et innskutt skrå. Det er svært viktig med **helt avslappet fot** og at bildet tas **UTEN GIPS**.	
POSISJONERING	Pasienten liggende så langt ned på bordet at omtrent 1/3 av aktuelt bein ligger på utsiden av bordenden. Pasienten ligger på siden med aktuelt beins laterale side mot bord/gulv. Beinet justeres for å oppnå åpen ankelgaffel som ved **SKRÅ**. Det er spesielt viktig at **foten er fullstendig avslappet**, da det er dette som stresser ankelleddet. Detektor plasseres vertikalt bak aktuelt bein. Med sentrering i ankelleddet, inkluder 1/3 av distale tibia og fibula	
SENTRERING	Midt mellom malleolene	
STRÅLERETNING	0°, med AP-stråleretning, vinkelrett på detektor.	
BILDEKRITERIER	Ankelleddet fremstilles helt åpent, med malleolene i profil. 1/3 av distale tibia og fibula inkluderes, samt bløtdeler inkluderes på hver side. Bildet vises med lengdeaksen liggende horisontalt, og merkes «gravity stress».	
KOMMENTAR		

Referanser

Vedlegg

V01	RG Fot / tær (A.1.1/6.1.3.6-06)

Slutt på Prosedyre